

TEMA 9.47 • RESPIRATORIO

Casos de Amigdalitis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Amigdalectomía

La **amigdalectomía** es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la práctica otorrinolaringológica, especialmente en pediatría. Aunque tradicionalmente se asociaba casi exclusivamente a infecciones recurrentes, las indicaciones han evolucionado. Actualmente, se dividen en tres grandes grupos: **infecciosas, obstructivas y neoplásicas**.

Es fundamental recordar que la mayoría de los cuadros de amigdalitis tienden a autolimitarse o disminuir su frecuencia con el paso de los años, por lo que la decisión quirúrgica debe basarse en criterios objetivos y no en eventos aislados.

1. Indicaciones Infecciosas

Este grupo incluye a pacientes que sufren de infecciones bacterianas a repetición que impactan significativamente su calidad de vida.

Amigdalitis Recurrente (Criterios de Paradise)

Para considerar la cirugía por recurrencia, se deben cumplir estrictamente los siguientes criterios de frecuencia (conocidos como la regla del 7-5-3):

TABLA 9.47.1: PERIODO DE TIEMPO VS FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS

PERIODO DE TIEMPO	FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS
En el último año	7 o más episodios
En los últimos 2 años	5 o más episodios por año
En los últimos 3 años	3 o más episodios por año

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Para que estos episodios cuenten para la cirugía, deben ser **amigdalitis bacterianas comprobadas** (idealmente con test rápido de antígeno o cultivo para *Streptococcus pyogenes* positivo) y haber recibido tratamiento antibiótico completo y adecuado.

Absceso Periamigdalino

El **Flegmón y Absceso Periamigdalino** es una complicación supurativa local. - La indicación quirúrgica estándar suele ser tras **2 o más episodios** de absceso periamigdalino. - Algunos especialistas consideran la cirugía tras el primer episodio si existen otros factores de riesgo o recurrencia infecciosa previa.

Amigdalitis Crónica

Se define como una inflamación de las amígdalas que persiste por **3 meses o más**. - Se caracteriza por dolor de garganta persistente, halitosis, formación de caseum (tonsilolitos) y adenopatías cervicales. - La indicación quirúrgica surge cuando el cuadro **no responde al tratamiento médico** bien llevado (antibióticos y medidas de higiene).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado! No se debe indicar cirugía basándose solo en el relato de los padres. Los episodios deben ser documentados por un médico, verificando la presencia de exudado, adenopatías y fiebre, para asegurar que no se trata de cuadros virales banales.

2. Indicaciones Obstructivas

Hoy en día, las causas obstructivas son la **indicación más frecuente** de amigdalectomía (generalmente asociada a adenoidectomía). Se deben a

una **hipertrofia amigdalina** grado III o IV que genera compromiso mecánico.

- **Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS):** Es la indicación principal. El paciente presenta ronquido estridente, pausas respiratorias durante el sueño, sueño fragmentado y, en niños, irritabilidad o bajo rendimiento escolar.
- **Disfagia obstructiva:** Amígdalas tan grandes que dificultan el paso del bolo alimenticio, provocando lentitud al comer o rechazo a ciertos alimentos sólidos.
- **Trastornos del lenguaje:** En raras ocasiones, la hipertrofia masiva puede causar una "voz de papa caliente" persistente.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del SAHOS en niños suele ser puramente mecánica por hipertrofia del tejido linfoide (amígdalas y adenoides), a diferencia del adulto donde influyen más el colapso de la vía aérea y la obesidad. Por ello, la cirugía es altamente curativa en la población pediátrica.

3. Sospecha de Neoplasia

Ante la sospecha de un proceso maligno, la amigdalectomía se realiza con fines diagnósticos y terapéuticos (biopsia excisional).

- **Asimetría amigdalina significativa:** Una amígdala notablemente más grande que la otra, especialmente si presenta un crecimiento rápido o cambios en la mucosa (ulceraciones).
- **Clínica sugerente de Linfoma:** Presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, baja de peso) asociada a aumento de volumen amigdalino asimétrico.
- **Carcinoma espinocelular:** Más común en adultos con factores de riesgo (tabaco, alcohol, VPH).

Requisitos para la indicación quirúrgica

- Para que un paciente sea candidato a cirugía por causas infecciosas, el médico debe verificar:
- **Evaluación objetiva:** Los cuadros fueron evaluados por un profesional y no son simples resfriados virales.
- **Tratamiento antibiótico adecuado:** Se debe confirmar que el paciente completó los cursos de antibióticos (ej. 10 días de Amoxicilina).
- - Si el paciente tomó antibióticos solo por 2 o 3 días y suspendió al sentirse bien, es probable que no haya habido erradicación del **Streptococcus pyogenes**, favoreciendo la recurrencia. En este caso, la falla es del tratamiento y no necesariamente una indicación quirúrgica inmediata.

Resumen de Indicaciones (Tabla)

TABLA 9.47.2: CATEGORÍA VS INDICACIÓN PRINCIPAL		
CATEGORÍA	INDICACIÓN PRINCIPAL	DETALLE CLAVE
Infeciosa	Amigdalitis recurrente	Criterios de Paradise (7-5-3).
Infeciosa	Absceso periamigdalino	Generalmente ≥ 2 episodios.
Infeciosa	Amigdalitis crónica	> 3 meses sin respuesta a tratamiento.
Obstructiva	SAHOS	Causa más frecuente actualmente.
Obstructiva	Disfagia	Por hipertrofia grado III-IV.
Neoplásica	Sospecha de cáncer	Asimetría amigdalina o sospecha de linfoma.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un paciente con amigdalitis recurrente que no cumple estrictamente los criterios de Paradise, la conducta inicial siempre debe ser la observación y el manejo médico óptimo, ya que la tendencia natural de este tejido es a la involución con la edad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 7 años presenta fiebre alta, odinofagia, adenopatías cervicales y exudado amigdalino. Al examen se observa un exantema difuso con textura de piel de gallina, petequias lineales en fosas antecubitales y respeto de la zona nasogeniana. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Casos de Amigdalitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amigdalitis viral: síntomas catarrales presentes (tos, rinorrea, disfonía), score de Centor 0-1 → tratamiento sintomático.
- Amigdalitis bacteriana: fiebre >38°C, exudado en surcos, adenopatías, sin catarro, edad 5-15 años → Centor 4-5 → antibióticos.
- Menores de 3 años con exudado amigdalino → lo más probable es adenovirus, no bacteria.
- Escarlatina: amigdalitis pultácea + exantema en piel de gallina + líneas de Pastia + triángulo de Filatov respetado + neutrofilia. Tratamiento = igual que amigdalitis pultácea.
- Kawasaki: ojo rojo + boca roja (labios partidos, lengua roja) + manos/pies rojos con edema/descamación + rash + adenopatía → ecocardiograma + aspirina + IgG IV.
- Mononucleosis: exudado blanco adherente en SUPERFICIE amigdalina + linfocitosis + esplenomegalia ± hepatomegalia ± ictericia.
- El rash morbiliforme de la mononucleosis aparece en 30% espontáneamente, pero sube a 90% tras ampicilina/amoxicilina.
- Fiebre faringoconjuntival (adenovirus): conjuntivitis + fiebre + faringitis → cuadro benigno, no requiere antibióticos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CASOS DE AMIGDALITIS)

PREGUNTA 1

Niño de 7 años presenta fiebre alta, odinofagia, adenopatías cervicales y exudado amigdalino. Al examen se observa un exantema difuso con textura de piel de gallina, petequias lineales en fosas antecubitales y respeto de la zona nasogeniana. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- ☐ A) Enfermedad de Kawasaki; aspirina más inmunoglobulina G endovenosa
- ☐ B) Mononucleosis infecciosa; tratamiento sintomático
- ☐ C) Escarlatina; penicilina benzatina o amoxicilina
- ☐ D) Sarampión; tratamiento de soporte y vitamina A
- ☐ E) Amigdalitis bacteriana complicada; amoxicilina-ácido clavulánico

PREGUNTA 2

Adolescente de 16 años con odinofagia, fiebre y adenopatías cervicales bilaterales. Se observa exudado blanco adherente en la superficie de ambas amígdalas. El hemograma muestra linfocitosis con linfocitos atípicos. Inició amoxicilina hace 2 días y ahora presenta un rash morbiliforme generalizado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Amigdalitis bacteriana con alergia a la amoxicilina
- ☐ B) Mononucleosis infecciosa
- ☐ C) Escarlatina
- ☐ D) Faringitis por adenovirus
- ☐ E) Linfoma con compromiso amigdalino

PREGUNTA 3

Niño de 4 años presenta fiebre de 6 días de evolución, ojo rojo bilateral no purulento, labios eritematosos y fisurados, lengua aframbuesada, edema de manos y un rash polimorfo en tronco. ¿Cuál es la conducta prioritaria?

- ☐ A) Iniciar penicilina benzatina intramuscular
- ☐ B) Solicitar monotest y hemograma para descartar mononucleosis
- ☐ C) Tratamiento sintomático y control ambulatorio
- ☐ D) Ecocardiograma, aspirina e inmunoglobulina G endovenosa
- ☐ E) Iniciar corticoides sistémicos por sospecha de vasculitis

RESUMEN: CASOS DE AMIGDALITIS

Esta clase presenta casos clínicos que permiten diferenciar las distintas causas de cuadros faríngeos: amigdalitis viral, amigdalitis bacteriana (pultácea), escarlatina, enfermedad de Kawasaki y mononucleosis infecciosa. Cada entidad tiene claves diagnósticas específicas que se repiten en las preguntas del EUNACOM y que deben dominarse. La amigdalitis viral se identifica por síntomas catarrales (rinorrea, disfonía) y score de Centor bajo (0-1 puntos). La bacteriana se presenta con fiebre alta, adenopatías, exudado en surcos y ausencia de síntomas catarrales (4-5 puntos de Centor). En menores de 3 años con exudado, lo más probable es adenovirus aunque simule una bacteriana. La escarlatina es una complicación de la amigdalitis pultácea por *Streptococcus pyogenes* productor de toxina eritrogénica: se presenta con exantema en piel de gallina, líneas de Pastia (petequias lineales en fosas antecubitales), respeto del triángulo de Filatov (zona nasogeniana) y neutrofilia. Su tratamiento es idéntico al de la amigdalitis pultácea. La enfermedad de Kawasaki se diferencia por la presencia de ojo rojo, boca roja (labios rojos y partidos, lengua roja), edema o descamación de manos y pies, rash cutáneo y adenopatía. Requiere ecocardiograma (dilatación de arterias coronarias), aspirina e inmunoglobulina G endovenosa. La mononucleosis infecciosa (Epstein-Barr) se caracteriza por exudado blanco adherente en la superficie amigdalina (no en surcos), linfocitosis, esplenomegalia/hepatomegalia, ictericia y un rash morbiliforme que aparece hasta en el 90% de los casos tras administración de ampicilina o amoxicilina (30% espontáneamente).